CLASE ESPECIAL

CIRUGÍA ENDOVASCULAR

DR. ANTEZANA

CUADRO CLÍNICO

- Claudicación intermitente: dolor/calambre inducido por marcha, alivia en reposo.
- Isquemia crítica (CLTI): dolor en reposo que empeora en decubito, mejora colgando la pierna; úlceras no cicatrizantes o gangrena.
- Síndrome de Leriche: claudicación glútea, disfunción eréctil, ausencia bilateral de pulsos femorales.

DIAGNÓSTICO VASCULAR NO INVASIVO

- Doppler arterial: ondas trifásica, bifásica o monofásica según severidad; eco-doppler dúplex localiza el nivel de la estenosis.
- Angio-TC o angio-RM para planificación preoperatoria; la angiografía por sustracción digital es el estándar de oro, reservada para el momento de la intervención.

ISQUEMIA AGUDA: LAS 5 "P" Y VENTANA CRÍTICA

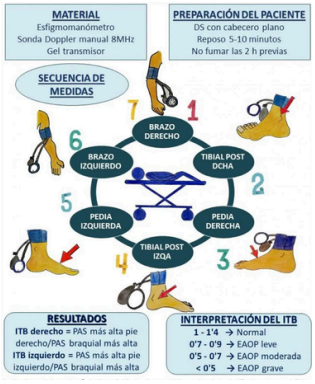
- Pain, Pallor, Paresthesia, Pulselessness, Paralysis. Ventana de 6h para revascularizar; después, riesgo de síndrome compartimental (requiere fasciotomia de 4 compartimentos).

CLASIFICACIÓN DE RUTHERFORD (ALI)

Clasificación de Rutherford		Clasificación de Fontaine	
Estadio	Clínica	Estadio	Clínica
0	Asintomático	I	Asintomático
1	Claudicación ligera	IIa	Claudicación leve, distancia mayor a 200 metros
2	Claudicación moderada	IIb	Claudicación moderada-severa, distancia menor a 200 metros
3	Claudicación severa		
4	Dolor isquémico en repoco	III	Dolor isquémico en reposo
5	Pérdida tisular menor	IV	Ulceración o gangrena
6	Pérdida tisular mayor		

ÍNDICE TOBILLO-BRAZO (ITB)

- 1.0-1.2: normal. 0.8-0.9: claudicación leve-moderada. <0.5: oclusión multinivel. <0.4: isquemia crítica.
- >1.2 o no compresible: calcificación de Monckeberg (diabéticos/ERC); usar índice dedo-brazo (>40mmHg diabéticos, >20mmHg no diabéticos).



FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN

- Tabaquismo: el factor modificable más importante, con relación dosis-respuesta directa con la progresión de la enfermedad.
- Diabetes mellitus: acelera la calcificación arterial y aumenta el riesgo de amputación; el control estricto de la glucemia reduce las complicaciones.

TASC II Y FARMACOTERAPIA

- TASC II femoropoplíteo: A (lesión única <5cm) a D (oclusión total >20cm). WIfI combina herida, isquemia e infección del pie.
- Cilostazol 100mg BID (contraindicado en ICC); Atorvastatina 80mg/día; ASA+Rivaroxabán reduce eventos CV y amputación (VOYAGER PAD).

ENDOVASCULAR VS CIRUGÍA ABIERTA

- Endovascular: angioplastia con balón (PTA), stents liberadores de paclitaxel o cubiertos.
- Abierta: bypass femoropoplíteo con vena autóloga (safena) o prótesis; gold standard de permeabilidad (80% a 5 años con vena).

CLASE ESPECIAL

CIRUGÍA ENDOVASCULAR

DR. ANTEZANA

EAP: ENFERMEDAD DE ADAPTACIÓN

- La disminución progresiva del flujo desarrolla colaterales («desvíos en una autopista») que retrasan la entrega de oxígeno y enmascaran los síntomas hasta que la demanda supera su capacidad.

EPIDEMIOLOGÍA DE LA EAP

- 1 de cada 3 diabéticos >50 años; comparte lecho con la enfermedad coronaria y cerebrovascular: 20–30% sufrirá IAM, ACV o muerte vascular en 5 años.

FACTORES NO MODIFICABLES

- Edad >65 años, sexo masculino, genética (LPA, APOE) y antecedente familiar de ateroesclerosis.

FACTORES MODIFICABLES

- Tabaquismo, diabetes, hipertensión, dislipidemia y enfermedad renal crónica.

ISQUEMIA AGUDA CLASE 1 (VIABLE)

- Sin pérdida sensitiva ni debilidad; Doppler arterial y venoso audibles.

CLASE 2a (MARGINALMENTE AMENAZADA)

- Pérdida sensitiva mínima (dedos), sin debilidad; Doppler arterial a menudo inaudible, venoso audible.

CLASE 2b (INMEDIATAMENTE AMENAZADA)

- Pérdida sensitiva más allá de los dedos y debilidad leve a moderada; arterial inaudible, venoso audible.

CLASE 3 (IRREVERSIBLE)

- Anestesia profunda, parálisis o rigidez; Doppler arterial y venoso inaudibles.

REVASCULARIZAR UNA CLASE 3: CONTRAINDICADO

- El lavado de metabolitos (lactato, potasio, mioglobina) causa acidosis severa, hiperpotasemia con paro cardíaco e insuficiencia renal por mioglobinuria: amputación primaria.

ONDAS DOPPLER

- Trifásica/multifásica: normal. Monofásica (parvus tardus): estenosis severa proximal (ascenso lento y caída diastólica prolongada).
- Aliasing: turbulencia con velocidad pico sistólica >300 cm/s.

ULTRASONIDO INTRAVASCULAR (IVUS)

- Imagen de 360° desde el interior del vaso: diámetro real y tipo de placa (cálcica vs lipídica) para guiar aterectomía o stent.

TASC II FEMOROPOPLÍTEO

- A: lesión única <5 cm. B: única <15 cm o múltiples <5 cm. C: múltiples >15 cm. D: oclusión total crónica >20 cm.

FARMACOTERAPIA DE PRIMERA LÍNEA

- Cilostazol 100 o 50 mg BID (inhibidor de la PDE3; contraindicado en ICC), pentoxifilina y atorvastatina 80 mg/día.
- Aspirina 81 mg + rivaroxabán 2,5 mg BID (VOYAGER PAD y COMPASS).